

Objectif n° 63/ La schizophrénie

Dr Rim BEN SOUSSIA

Service de psychiatrie de Mahdia

11-07-2025

Objectifs éducationnels

1. Définir la schizophrénie
2. Etablir le diagnostic positif de la schizophrénie, à partir des données anamnestiques et cliniques
3. Identifier les diagnostics différentiels de la schizophrénie à partir des données anamnestiques et cliniques
4. Décrire les modalités évolutives de la schizophrénie
5. Planifier la prise en charge médicamenteuse, psychologique et sociale de la schizophrénie
6. Préciser les éléments de surveillance d'un antipsychotique au long cours

Introduction- définition

Introduction-définition

- La schizophrénie désigne un groupe de psychoses chroniques caractérisées par:
 - une dislocation de la vie psychique
 - une désorganisation progressive de la personnalité
 - et un bouleversement des rapports avec la réalité

Introduction - définition

- Les symptômes schizophréniques se distinguent par une expression clinique hétérogène et fluctuante avec le temps

Introduction-définition

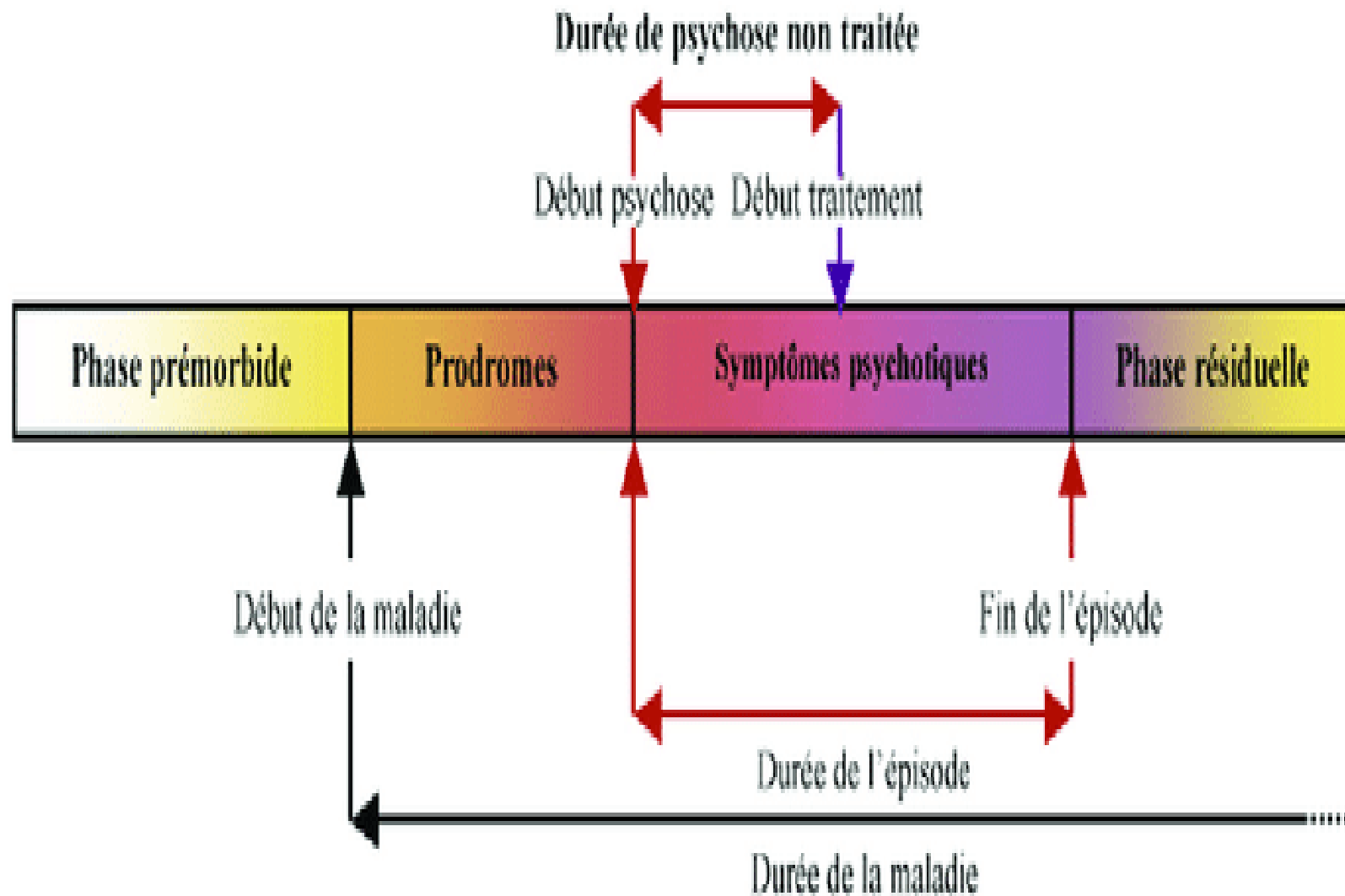
- Elle inclue des perturbations dans le domaine des affects, de la pensée et du comportement
- Ces perturbations appartiennent à trois dimensions principales :

positive, négative et désorganisée

et sont généralement associés à des déficits neurocognitifs.

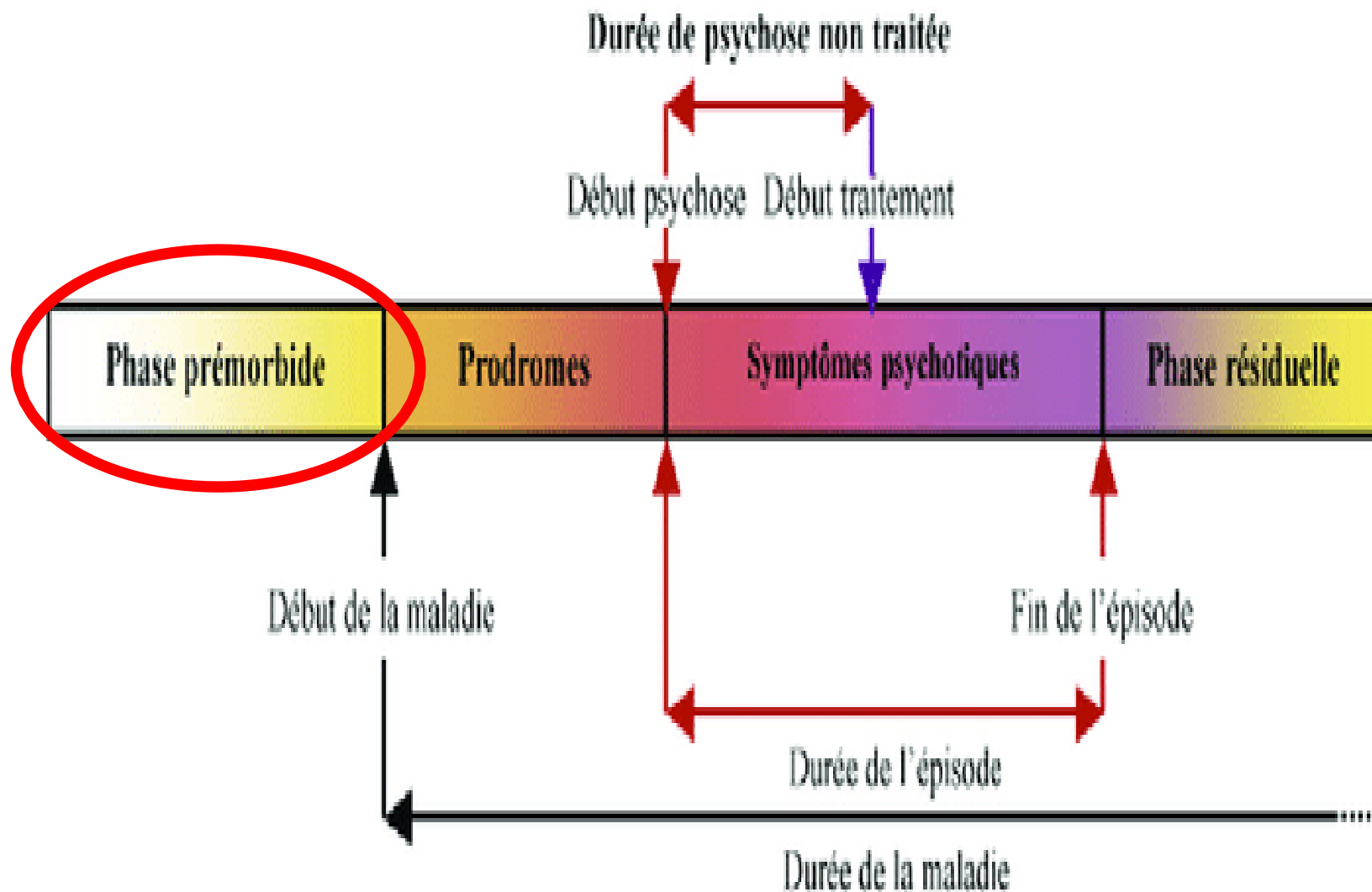
Introduction-définition

- La schizophrénie est un trouble psychotique chronique (**> 6mois**)
- Son évolution comporte généralement:
 - une phase prodromique,
 - une phase active avec des idées délirantes, des hallucinations ou les deux
 - une phase résiduelle au cours de laquelle le trouble peut être en rémission



Âge de début : adulte jeune

Étude clinique

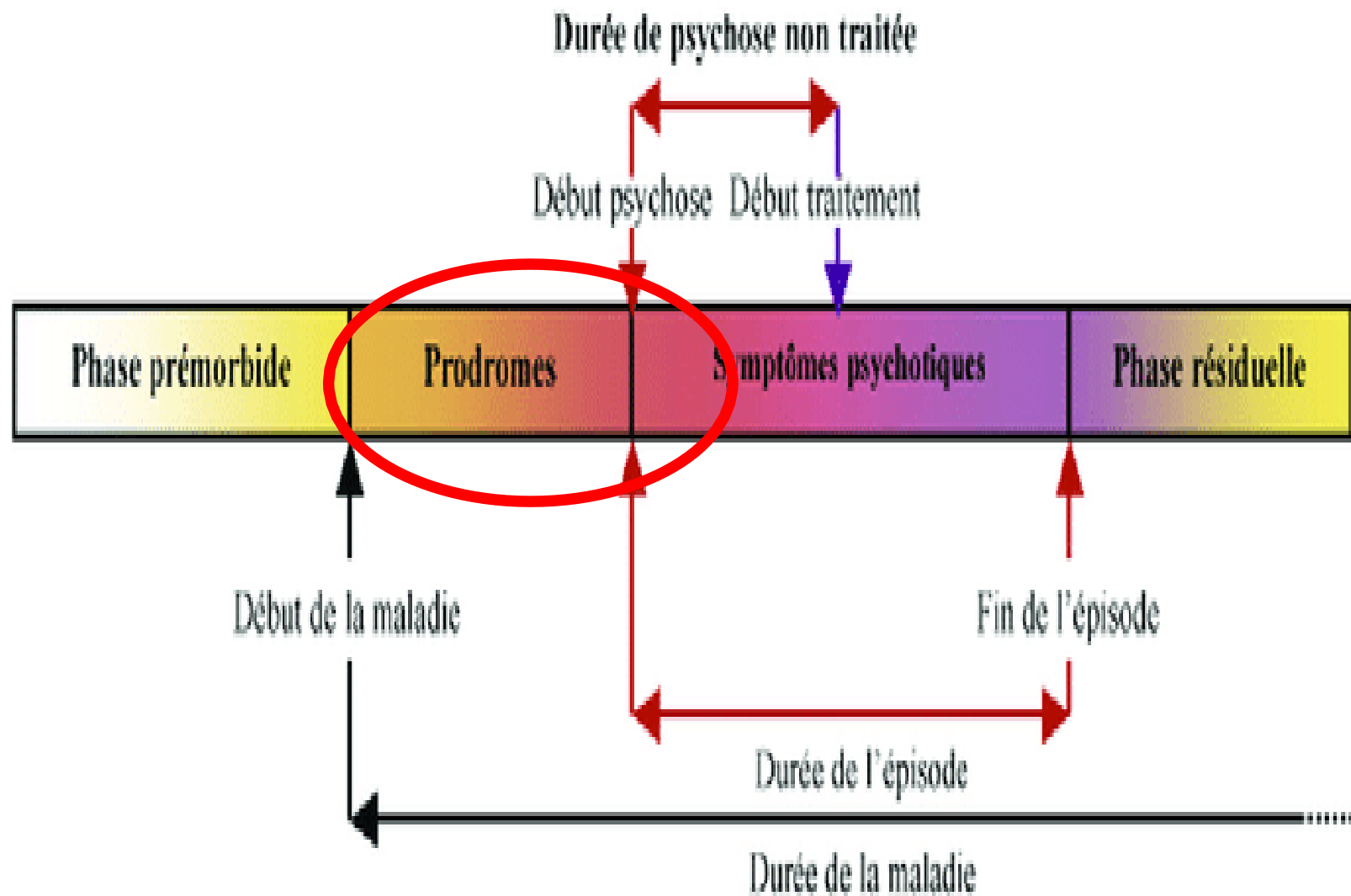


Phase Prémorbide

- C'est une phase de relative normalité avant l'éclosion des symptômes psychotiques
- Souvent les sujets en phase prémorbide ont des traits de personnalité schizoïde ou schizotypique

Phase Prémorbide

- Personnalité schizoïde : repli sur soi, froideur affective, peu de relations sociales, pas de plaisir pour les différentes activités, indifférence
- Personnalité schizotypique : conduites excentriques , distorsions cognitives et perceptives, pensée magique et bizarre, affects inappropriés



Mode de début

Mode de début
aigu

Mode de début
progressif

Mode de début

Mode de début aigu

Mode de début
progressif

Un épisode délirant aigu inaugural (BDA)

- Pose surtout le problème de son devenir (pronostic au long cours)
- Certains facteurs de mauvais pronostic sont associés à une évolution vers la schizophrénie:
 - Installation des troubles > 1 mois (début non brutal)
 - Absence de confusion mentale à l'acmé de l'épisode psychotique
 - Mauvais fonctionnement social et professionnel prémorbide
 - Existence d'un émoussement affectif

Mode de début

Mode de début aigu

Mode de début
progressif

Des épisodes d'allure maniaque ou dépressive (atypiques)

- Dépression atypique :
 - Contact détaché, distant
- Manie atypique :
 - état d'excitation psychique plus qu'un état d'excitation de l'humeur (euphorie et contact ludique absents ou au second plan)
 - Tachypsychie avec des associations idéiques incohérentes (≠associations par assonance ou par contiguïté)
 - l'agitation comporte un caractère bizarre

Mode de début

Mode de début
aigu

Mode de début
progressif

Début pseudo-névrotique :

Le tableau clinique évoque celui des névroses, mais avec des caractères particuliers :

◆ Phobies atypiques :

- Réassurance inefficace et non recherchée
- Mesures d'évitement absentes ou inorganisées.
- Situations phobogènes multiples sans lien entre elles

◆ Obsessions :

L'origine psychotique est suspectée devant:

- l'absence de lutte anxieuse
- La thématique pseudo-délirante
- la bizarrerie des rituels et des compulsions

◆ Préoccupations hypocondriaques :

- concernant moins la santé proprement dite que l'apparence ou l'identité du corps

Mode de début

Mode de début
aigu

Mode de début
progressif

Troubles des conduites :

Un début de schizophrénie est suspecté devant:

♦ Des conduites de délinquance ou de déviations Sexuelles (zoophilie)

♦ Un passage à l'acte ayant un caractère immotivé, bizarre

« se déshabiller soudainement en public »

« faire un acte religieux inapproprié en pleine rue »

Mode de début

Mode de début
aigu

Mode de début
progressif

Fléchissement de l'activité et modification du caractère :

- Désinvestissement des tâches habituelles
- Restriction du contact avec autrui, froideur, bizarreries dans la présentation
- Des croyances à des phénomènes surnaturels, bizarres

Mode de début

Mode de début
aigu

Mode de début
progressif

Idées délirantes à développement insidieux :

- Peuvent se développer de façon insidieuse et rester relativement isolées
- Souvent méconnues par l'entourage
- Le sujet est souvent perplexe vis à vis de cette expérience angoissante et la conviction est très fluctuante d'où la réticence
- Dépersonnalisation et déréalisation
- Les mécanismes sont multiples (hallucinations auditives++, hallucinations intrapsychiques, automatisme mental)
- Les thèmes sont multiples (hypocondrie, de modification corporelle ou de l'identité, dysmorphophobie, thèmes mystiques, thèmes de persécution, d'ensorcellement, de divulgation de la pensée, d'écho de la pensée ou d'influence)

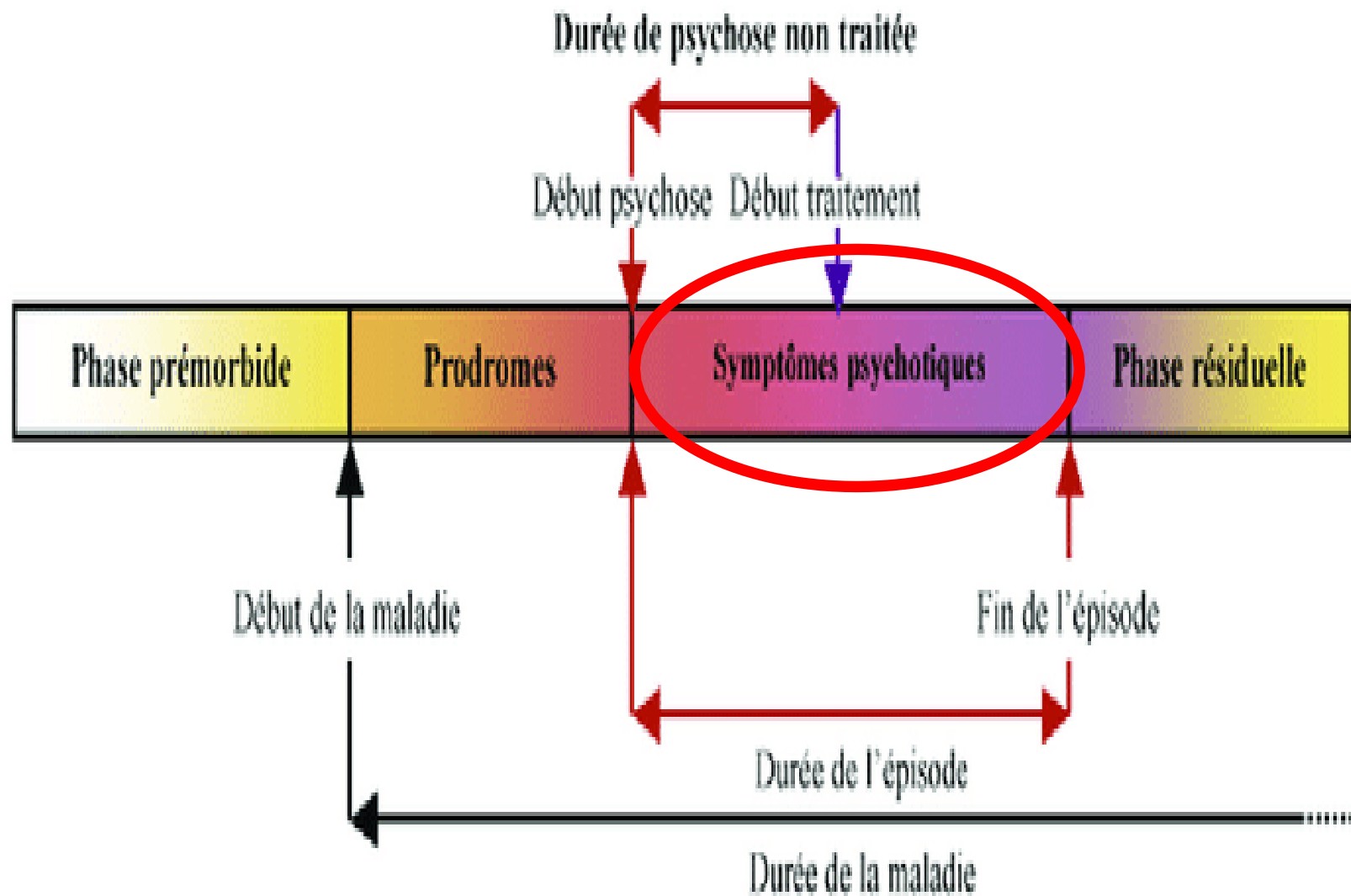
Mode de début

Mode de début
aigu

Mode de début
progressif

Altération des performances cognitives :

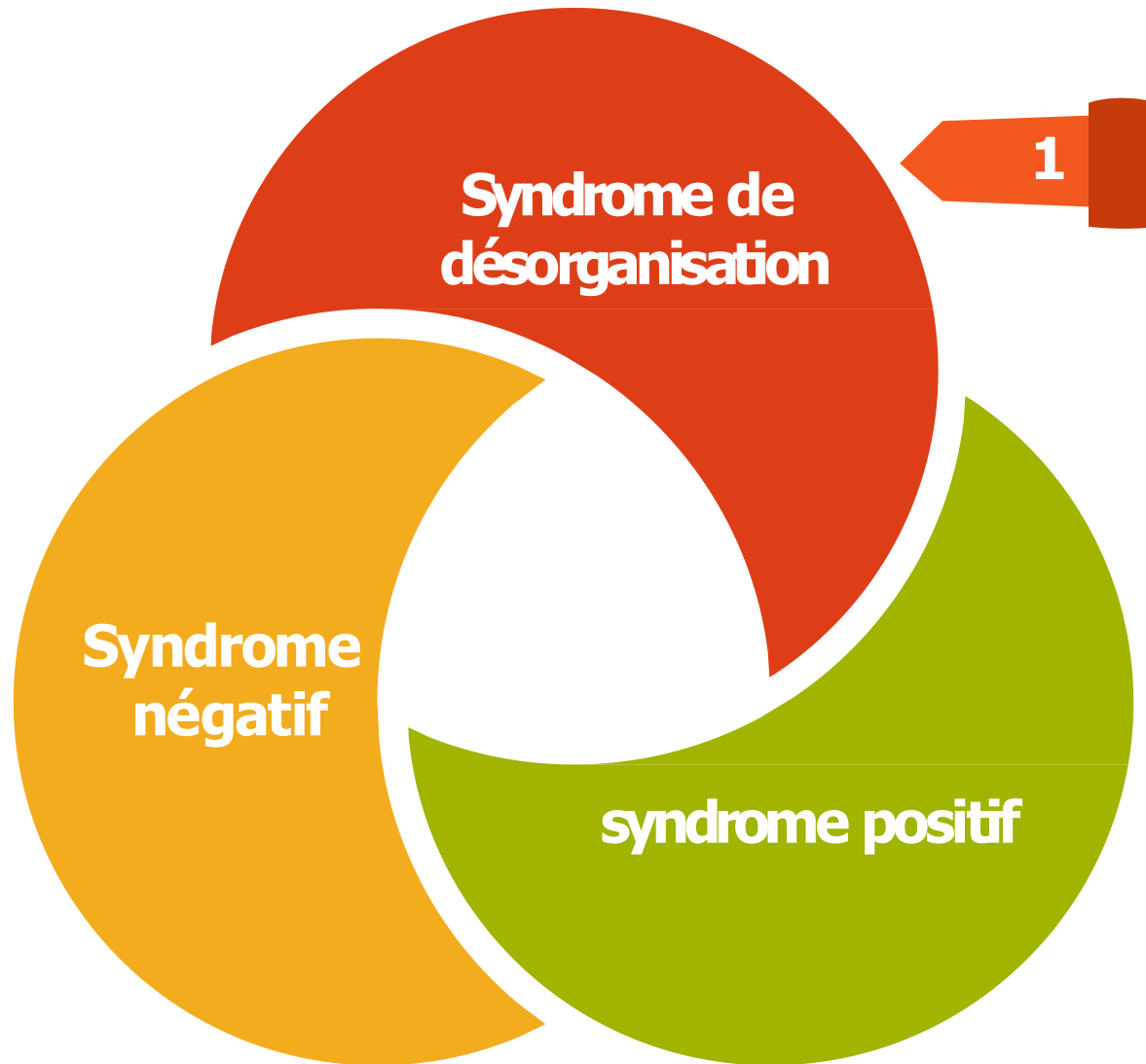
- Une baisse du rendement scolaire avec des échecs répétés
- Le handicap observé est la conséquence d'un déficit neurocognitif (trouble de la mémoire, de l'attention et/ou des fonctions exécutives)



Diagnostic positif : phase d'état



Diagnostic positif : phase d'état



Désorganisation

```
graph TD; A[Désorganisation] --> B[Cognition]; A --> C[Affect]; A --> D[Comportement];
```

A hierarchical diagram with 'Désorganisation' at the top. Three arrows point downwards from it to a row of three boxes containing 'Cognition', 'Affect', and 'Comportement'.

Cognition

Affect

Comportement

Désorganisation



Cognition

Le déroulement de la pensée (Trouble du cours de la pensée):

Des barrages

Le Fading mental

Les sauts du coq à l'âne , digression

Trouble du contenu de la pensée:

Relâchement des associations idéiques

Discours circonlocutoire

Les néologismes

La schizophasie

Discours tangentiel ou réponses à côté

Augmentation du temps de latence

Mutisme

Soliloquie

Rationalisme morbide

Pensée abstraite

L'écholalie, coprolalie , stéréotypie verbale

Désorganisation



Affect

Affect abrasé

Froideur affective

Réactions émotionnelles paradoxales

Discordance idéo-affective

Ambivalence affective

Syndrome dissociatif



Comportement

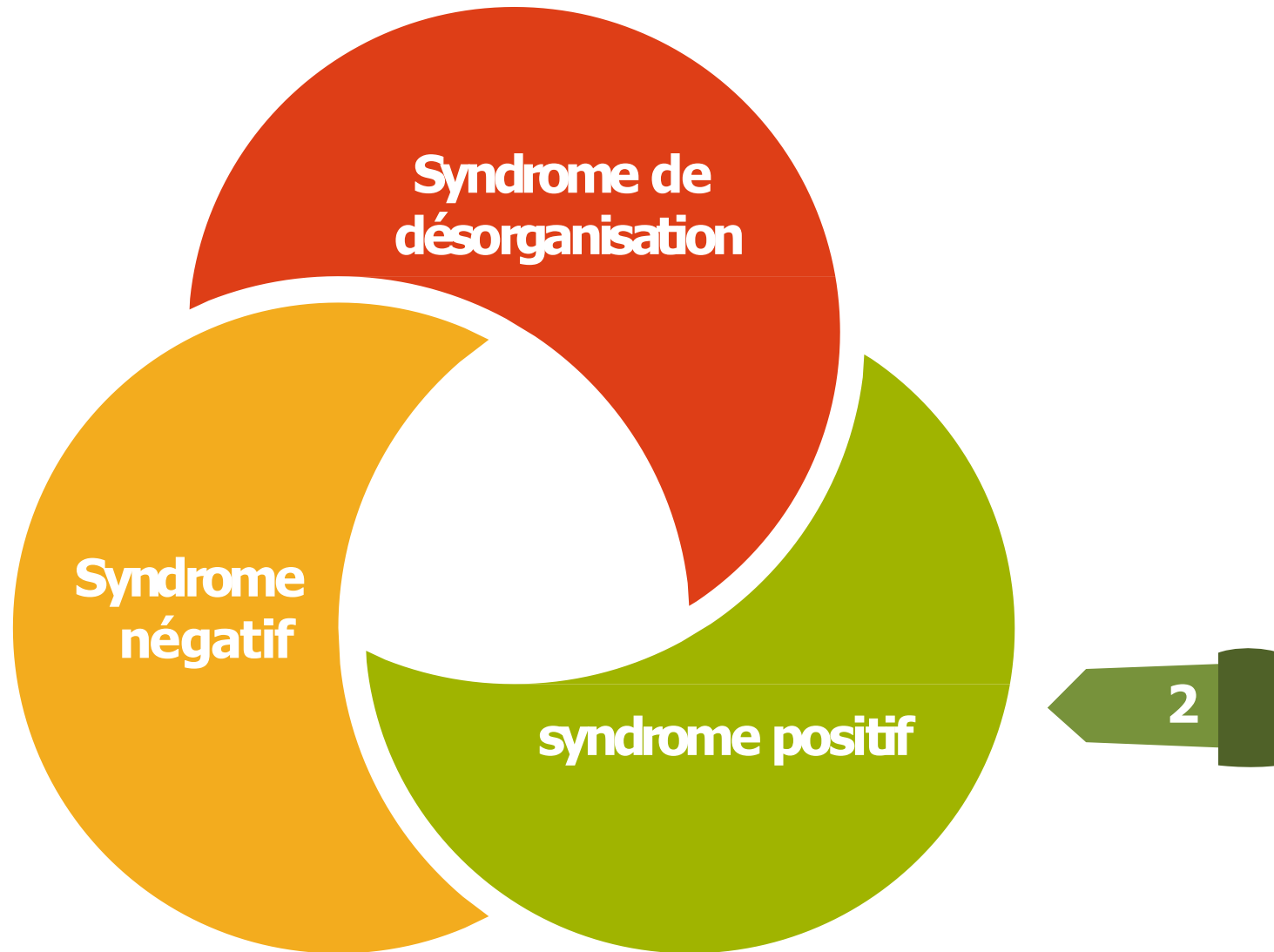
Maniérisme

Stéréotypies motrices

Parasitisme mimique

Comportements impulsifs, bizarres

Diagnostic positif : phase d'état



- L'idée délirante est une croyance ou un système de croyances erronées en opposition avec la réalité ou l'évidence
- Elle fait l'objet d'une conviction inébranlable, inaccessible au raisonnement ou à la contestation par les faits

- Caractéristiques d'un délire: «**TOMATES** »
 - **T**hèmes
 - **O**rganisation ou degré de systématisation
 - **M**écanismes
 - **A**dhésion
 - **T**hymie
 - **E**volution
 - **S**ignes associés



- Délire flou mal systématisé, bizarre
- Thèmes: persécution, ensorcellement, mégalomaniacque, mystique, référence, influence....
- Mécanismes (multiples) : interprétatif, imaginatif, intuitif, mais surtout **hallucinatoire**⁺⁺
- La participation thymique peut se traduire par une angoisse, sthénicité, voire agitation et violence ou au contraire une froideur affective ou une ambivalence

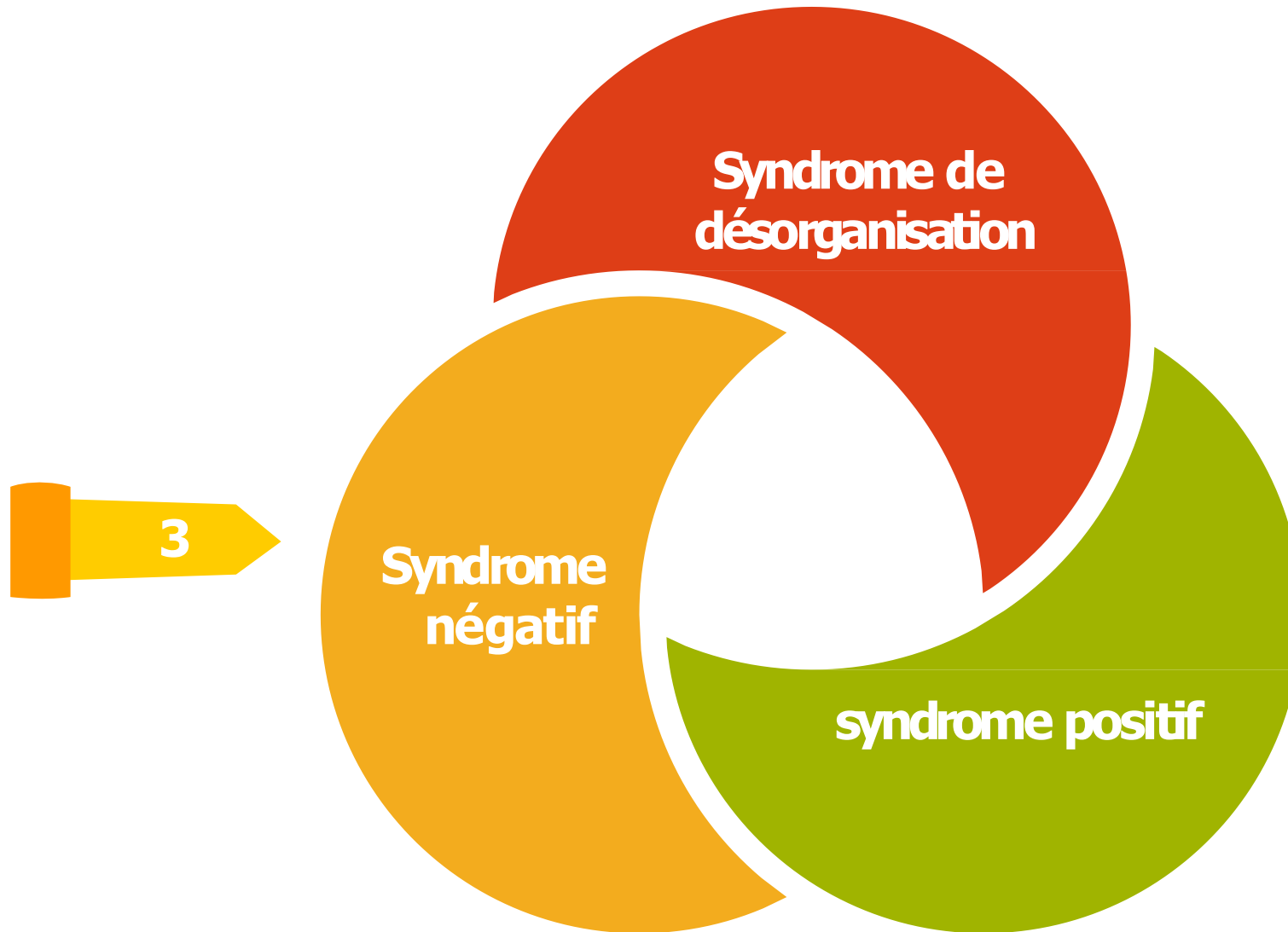
- ***L'automatisme mental :***

C'est le fait de ne plus être sûr de rester maître de lui-même. Il Comporte une série de phénomènes psychiques qui s'imposent à la conscience du sujet, malgré lui et de façon presque mécanique.

Il comporte:

- **des automatismes moteurs et idéiques**, tels que des énonciations et des jeux verbaux et un devinement de la pensée
- **des phénomènes d'écho de la pensée et des actes**, où le sujet a l'impression que ses actes, ses pensées et ses intentions sont énoncés, devancés, répétés en écho ou commentés par des voix intérieures indépendantes de lui.

Diagnostic positif : phase d'état



Signes négatifs : Les «A »

Classification des symptômes négatifs

Apathie

- Avolition (réduction d'activité)
- Anhédonie (réduction de plaisir)
- Asocialité (activité sociale réduite)

Diminution de l'expressivité

- Alogie (réduction de quantité de mots exprimés)
- Eroussement affectif

Les troubles cognitifs dans la schizophrénie

- Avant l'ère des neuroleptiques, la schizophrénie = «la démence précoce »
- Troubles cognitifs dans la schizophrénie : non spécifiques mais fréquents (70% des cas)
- Ils sont précoces dès la phase prodromique de la maladie et persistent tout au long de l'évolution

- Leur sévérité conditionne l'adaptation psychosocial du patient
- Les domaines cognitifs les plus altérés sont:
 - la mémoire
 - les fonctions exécutives de planification et de flexibilité mentale
 - l'attention et la vitesse de traitement de l'information

Diagnostic positif

Critères diagnostiques de la schizophrénie selon DSM 5

- **idées délirantes**
- **Hallucinations**
- **Discours désorganisé**
- Comportement grossièrement désorganisé ou catatonique
- Symptômes négatifs

2 symptômes au moins * 1mois au moins

Altération significative du fonctionnement
socioprofessionnel et perturbation
permanente sur le plan symptomatique

Durée d'au moins 6 mois



**Élimination
des dg
différentiels**

Diagnostics différentiels



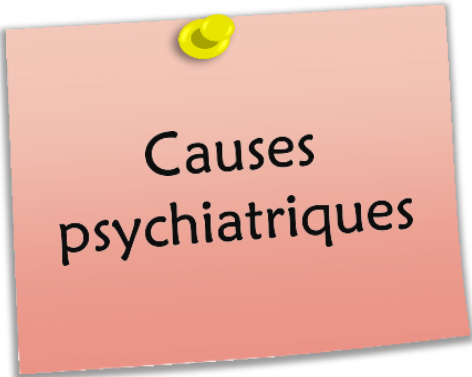
Causes organiques

- ✓ **TC**
- ✓ **PEIC**
- ✓ **AVC**
- ✓ **Épilepsie temporale**
- ✓ **Dysthyroidies**
- ✓ **Maladie d'Addison**
- ✓ **I^{ce} hypophysaire**
- ✓ **Encéphalite infectieuse**
- ✓ **Maladies systémiques**



Causes toxiques et iatrogènes

- ✓ **Alcool**
- ✓ **Cannabis**
- ✓ **les drogues psychodysléptiques (LSD, cocaïne)**
- ✓ **Corticoïdes**
- ✓ **Bromocriptine**
- ✓ **Les antiparkinsoniens**



Causes psychiatriques

- ✓ **Troubles de l'humeur**
- ✓ **Le trouble schizo-affectif**
- ✓ **Le trouble délirant**
- ✓ **Les troubles névrotiques (phase prodromique)**
- ✓ **Les troubles de la personnalité (schizoïde, schizotypique)**
- ✓ **Retard mental**

Modalités évolutives

- L'évolution de la schizophrénie est sujette à une grande variabilité interindividuelle
- L'évolution:
 - vers une **guérison totale: rare+++**
 - **déficitaire** est actuellement rare
 - persistance de **symptômes résiduels entrecoupés par des poussées aiguës**
 - formes **résistantes** et/ou **continue**

- **Les formes résistantes au traitement:** (non-réponse à deux antipsychotiques à dose et durée adéquate pendant une durée de 6 à 8 semaines).

- Par ailleurs, cette évolution est émaillée par:
 - une surmortalité par suicide (10 à 12 fois plus élevé que dans la population générale)
 - la fréquence des comorbidités somatiques

- **Les facteurs de bon pronostic :**

- Sexe féminin
- Environnement favorable
- Bon fonctionnement pré-morbide
- Début tardif
- Bonne conscience du trouble
- Traitement antipsychotique précoce et bien suivi
- Courte durée de psychose non traitée

Moyens thérapeutiques

Biologique



Social



Psychologique

Volet biologique

- Le traitement biologique de la schizophrénie repose sur la prescription au long cours des neuroleptiques (antipsychotiques)
- Le choix du produit sera déterminé par le profil de la molécule (sédatif) ou (incisif), du tableau clinique présenté par le malade et de sa tolérance au produit
- Certains neuroleptiques «désinhibiteurs» sont susceptibles de corriger l'aspect déficitaire

Volet biologique

- Dans la pratique on a tendance à privilégier une séquence visant l'aspect productif ou au contraire déficitaire suivant la présentation clinique
- Choisir la molécule la plus efficace, la mieux tolérée et à la dose minimale efficace
- Privilégier au tant que possible la monothérapie
- Les neuroleptiques prescrits : but curatif et préventif

Volet biologique

- Les neuroleptiques sédatifs : (chlorpromazine (Largactil*), lévomopromazine (Nozinan*), la propériciazine (Neuleptil*))
- Les neuroleptiques incisifs ou polyvalents: (halopéridol (Haldol*), fluphénazine (Moditen* ou Modécate*), la pipothiazine (Piportil*))
- Les neuroleptiques désinhibiteurs ou «bipolaires »: La pipothiazine (Piportil*), le sulpiride (Dogmatil*), l'amisulpride (Solian*)

Volet biologique

Les antipsychotiques atypiques :

- Action globale sur les symptômes productifs et déficitaires
- préconisés en première intention en raison de leur efficacité et de leur meilleure tolérance notamment neurologique
- Effets indésirables notamment métaboliques
- Sur le marché tunisien nous disposons actuellement de :
 - **la clozapine** indiquée principalement dans la schizophrénie résistante, le risque principal avec cette molécule est celui de l'agranulocytose
 - l'**olanzapine**, la **rispéridone**, l'**amisulpride**, l'aripiprazole et la quetiapine

Recommandation : choix du médicament pour éviter les effets indésirables

	Médicaments les moins susceptibles de causer cet effet	Médicaments les plus susceptibles de causer cet effet
Sédation	Risperidone Ziprasidone, neuroleptiques incisifs	Neuroleptiques sédatifs Clozapine
Prise de poids	Ziprasidone, risperidone	Clozapine Olanzapine
Syndrome extrapyramidal	Clozapine Quetiapine Olanzapine Ziprasidone Risperidone	Neuroleptiques incisifs et moyens
EI cognitifs	Antipsychotiques atypiques	Neuroleptiques sédatifs
EI anticholinergiques	Risperidone Ziprasidone Quetiapine, neuroleptiques incisifs	Neuroleptiques sédatifs Clozapine
EI sexuels/reproduction	Quetiapine, olanzapine, ziprasidone, clozapine	Neuroleptiques classiques
EI cardiovasculaires	Risperidone Olanzapine, neuroleptiques incisifs, quetiapine	Neuroleptiques sédatifs
Dyskinésies tardives	Clozapine Quetiapine Olanzapine Ziprasidone	Neuroleptiques classiques
Syndrome malin des neuroleptiques	Olanzapine Clozapine Quetiapine, ziprasidone, risperidone	Neuroleptiques classiques

Volet psychothérapeutique

- Psychoéducation
- Les psychothérapies de soutien
- Les psychothérapies cognitives et comportementales permettent de réduire certains symptômes du registre déficitaire et les hallucinations
- Les psychothérapies familiales visent à améliorer le fonctionnement de certaines familles, quand celui-ci s'avère pathogène pour le patient

- Mesures visant à la réadaptation sociale:
 - Congés de maladie
 - Reclassement professionnel
 - Formation professionnelle en milieu protégé
 - Ateliers thérapeutiques
 - Carte handicap
 - Mesures de protection des biens du malade

Stratégie thérapeutique

Bilan pré-thérapeutique :

- Indispensable afin de poser la bonne indication thérapeutique.
- IL comporte :
 - Anamnèse à la recherche des CI aux NL
 - Évaluation psychiatrique précise
 - Contexte socio-familial
 - Motivation du patient à s'engager dans un traitement au long cours

Bilan pré-thérapeutique :

- **Examen somatique** complet précisant en particulier la T°^o, TA, le poids, BMI, associé à un examen neurologique
- **Bilan paraclinique** : NFS, bilan hépatique, bilan rénal, bilan lipidique, glycémie et ECG. Un examen ophtalmologique et EEG peuvent être demandés suivant les cas

- **La monothérapie** est toujours préférée
- La dose du traitement est adaptée en fonction de l'évolution de la symptomatologie et des effets secondaires
- Les antipsychotiques atypiques sont mieux tolérés que les neuroleptiques classiques: **indiqués en première intention**
- **En cas de résistance** ou d'intolérance à 2 ou trois neuroleptiques, un traitement par **Clozapine** peut être indiqué.
- **L'électro-convulsivothérapie** est réservée aux **formes résistantes** avec prédominance des symptômes positifs (de 10 à 15 séances)

Les **antipsychotiques à action prolongée** peuvent être envisagés comme traitement de première ligne dans un cadre décisionnel partagé

Diagnostic confirmé → mettre sous antipsychotiques
« Start low, go slow »

Pour avoir un effet sédatif, la mise sous **benzodiazépines** est privilégiée par rapport à l'augmentation des doses des antipsychotiques

Amisulpride
Dose: 300-400
à 800 mg/jr

Aripiprazole
Dose: 15-20
à 30 mg/jr

Quétiapine
Dose: 300-400
à 800 mg/jr

Risperidone
Dose: 1-4
à 6 mg/jr

Ziprazidone
Dose: 80-120
à 160 mg/jr

Réponse insuffisante après 3 semaines → augmenter les **doses**

Absence de réponse après 6 – 8 semaines → **Switch** vers un autre antipsychotique atypique
Considérer l'**Olanzapine** : dose 10 à 20 mg/jr

Absence de réponse → Considérer le switch vers la **Clozapine** :
dose 300 à 900 mg/jr

Le traitement au long cours:

- Après un premier épisode psychotique : le traitement neuroleptique doit être maintenu pendant une période d'au moins 2 ans
- L'arrêt peut être tenté, en l'absence de rechute ou de signes résiduels avec bonne adaptation socio-professionnelle
- Dans le cas contraire, le traitement neuroleptique est maintenu au long cours voire à vie
- Si possible, privilégier les antipsychotiques atypiques à la dose minimale efficace à cause de leur bonne tolérance

Surveillance au cours du traitement:

Surveillance psychique : (efficacité sur l'agitation et l'anxiété, les symptômes productifs)

- Si présence de sédation importante, de dépression ou d'un tableau d'apathie nécessité de diminuer les doses
- Si développement de signes confusionnels l'arrêt du traitement est envisagé

**Effets indésirables
et
Surveillance du traitement**

Points à surveiller	A l'instauration du traitement	Surveillance ultérieure
Constantes vitales	FC, TA, T° lors des premiers jours du traitement	Mesure des mêmes constantes à chaque consultation et/ou lors des changements de posologie
Signes extrapyramidaux précoces	Evaluation clinique avant le début du traitement	Evaluation hebdomadaire en phase aiguë, puis à chaque consultation
Signes extrapyramidaux tardifs	Evaluation clinique avant le début du traitement	Evaluation clinique annuelle
Poids	Mesure du poids, de la taille et du BMI	Calcul BMI au moins 2 fois/an
Diabète	Recherche de FR diabétique et glycémie	Glycémie 4 mois après le début du traitement, puis au moins une fois/ an
Hyperlipidémie	Cholestérolémie (total, HDL et LDL) et triglycéridémie	Mêmes bilan à refaire 1fois/an
Surveillance hépatique, rénale et hématologique	Dosage transaminases, créatininémie et NFS	Mêmes bilan 1 fois/ an. Sauf pour patients sous clozapine (NFS tous les semaines * 18 semaines, puis tous les mois)
Grossesse	Dosage β HCG chez les femmes en âge de procréation	S'assurer de la mise en œuvre d'une contraception efficace
Conduction cardiaque	Mesure du QT sur l'ECG	A contrôler si signes cliniques d'appel et ou changement de molécule
Hyperprolactinémie	Recherches de signes cliniques d'hyperprolactinémie et dosage sanguin si nécessaire	Recherches de signes cliniques d'hyperprolactinémie 1 fois/an et dosage sanguin si nécessaire
Cataracte	Recherche de troubles de la vision par l'interrogatoire	Recherche de troubles de la vision par l'interrogatoire, examen ophtalmologique annuel chez les patients de plus de 40 ans et sous traitement à haut risque oculaire
Fonctions supérieures	Evaluation clinique des capacités mnésiques et attentionnelles. Bilan neuropsychologique élémentaire annuel	Evaluation clinique annuelle des capacités mnésiques et attentionnelles. Bilan neuropsychologique élémentaire annuel

QUIZ!

1- la schizophrénie :

- A- appartient au groupe des psychoses non dissociatives
- B- comporte obligatoirement un syndrome délirant
- C- est un trouble psychiatrique dont l'âge de début est supérieur à 30 ans
- D- est associé à un déclin cognitif rapidement progressif
- E- est génératrice d'une altération du fonctionnement global du patient

Réponse: E

2- Devant un épisode délirant aigu, les facteurs prédictifs d'une évolution vers une schizophrénie sont:

A- les antécédents familiaux de troubles psychotiques

B- la persistance de déclin fonctionnel après la mise sous ttt

C- le mauvais fonctionnement prémorbide

D- la présence de symptômes confusionnels francs lors de l'épisode aigu

E- la présence de traits de personnalité schizoïde

Réponse: A-B-C-E

3- Les éléments de bon pronostic devant un tableau de schizophrénie sont :

- A. Le sexe féminin
- B. La présence de signes négatifs ou de désorganisation au premier plan du tableau
- C. La durée prolongée de psychose non traitée
- D. Le bon insight
- E. L'âge de début tardif de la maladie

Réponse: A-D-E

4- Le rationalisme morbide :

- A. Est un signe pathognomonique de la schizophrénie
- B. Reflète le degré d'atteinte cognitive dans la schizophrénie
- C. Est un signe de désorganisation de la pensée
- D. Est l'un des signes de l'automatisme mental
- E. se caractérise par un jugement pseudo-logique

Réponse: C-E

5- Devant un épisode thymique, les signes évocateurs d'un mode de début de la schizophrénie sont :

- A. le contact détaché
- B. l'absence d'euphorie et de contact ludique
- C. la présence de délire flou mal systématisé
- D. la présence d'un syndrome catatonique
- E. les bizarreries du comportement

Réponse: A-B-E

6- Devant des symptômes obsessionnels, un mode de début de la schizophrénie est suspecté devant :

- A. la présence d'un fléchissement scolaire
- B. l'âge de début précoce
- C. l'absence de lutte anxieuse
- D. la bizarrerie des compulsions et des rituels
- E. La présence des troubles de la perception

Réponse: C-D-E

7- les signes suivants chez un jeune de 17 ans, peuvent évoquer un mode de début de la schizophrénie :

- A. le développement de croyances à des phénomènes surnaturels
- B. La restriction du champ social
- C. Les troubles du comportement
- D. La dépersonnalisation
- E. la consommation de substances psychoactives

Réponse: A-B-C-D

8- La schizophasie:

A- est un signe positif de la schizophrénie

B- est un trouble du cours de la pensée

C- comporte plusieurs néologismes rendant le discours incompréhensible

D- est irréversible même sous ttt

E- est un élément de mauvais pronostic dans la schizophrénie

Réponse: C-E

9- Parmi les signes suivants lequel ou lesquels caractérise(nt) la désorganisation dans la sphère de la pensée :

- A. alogie
- B. la discordance idéo-affective
- C. l'ambivalence
- D. le saut du coq à l'âne
- E. le fading mental

Réponse: D-E

10- Parmi les signes en faveur de la présence d'hallucinations psycho-sensorielles :

- A. L'avolition
- B. les attitudes d'écoute
- C. les attitudes de contemplation
- D. L'incurie
- E. la soliloquie

Réponse: B-C-E

11- La schizophrénie :

A- peut être diagnostiquée avant l'âge de 18 ans

B- est associée à un risque de conduites suicidaires

C- peut évoluer sur un mode continu

D- Peut évoluer vers un tableau déficitaire

E- l'évolution vers la guérison est fréquente

Réponse: A-B-C-D

12- Parmi ces examens lesquels ne sont pas indispensables au bilan préalable à l'instauration d'un antipsychotique?

- A. Ionogramme sanguin
- B. bilan rénal
- C. ECG
- D. TSH
- E. EEG

Réponse: D-E

13- Parmi ces propositions, lesquelles peuvent correspondre à des effets indésirables des neuroleptiques classiques ?

- A. dyskinésie tardive
- B. Akathésie
- C. Troubles sexuels
- D. l'apparition d'une symptomatologie dépressive
- E. une élévation du seuil épileptogène
- F- l'exagération des symptômes positifs

Réponse: A-B-C-D

14- les explorations suivantes font partie du bilan pré-thérapeutique de la clozapine :

A. NFS

B. EEG

C. Ionogramme sanguin

D. ECG

E. protéinurie de 24 h

Réponse: A-B-C-D

15- Selon les critères diagnostiques du DSM5, la schizophrénie se caractérise par :

- A. Une évolution de la phase active de la maladie d'au moins 2 mois
- B. La présence d'un fonctionnement significativement altéré pendant au moins 6 mois
- C. La présence obligatoire durant une période conséquent de la maladie d'idées délirantes ou hallucinations ou un discours désorganisé
- D. La présence de symptômes thymiques tout au long de l'évolution du trouble
- E. La consommation de substances psychoactives élimine le diagnostic de schizophrénie

Réponse: B-C

16- Parmi ces anomalies électro-cardiographiques, la(les)quelle(s) peut(vent) être attribuée(s) aux neuroleptiques ?

- A. Allongement du QT
- B. Sus-décalage ST
- C. Bloc auriculo-ventriculaire paroxystique
- D. Torsade de pointe
- E. tachy-arythmie complète par FA (TACFA)

Réponse: A-D

- 17- Par rapport au petit automatisme mental, le grand automatisme mental se caractérise par :
- A. un plus grand risque de passage à l'acte agressif
 - B. une mauvaise réponse au traitement antipsychotique
 - C. la présence d'une symptomatologie motrice et cénesthésique
 - D. l'évolution chronique du tableau
 - E. le début à un âge plus précoce de la symptomatologie

Réponse: C

18- Les antipsychotiques de deuxième génération ou atypiques :

- A. Ne donnent pas d'effets indésirables neurologiques
- B. sont plus pourvoyeurs de troubles sexuels que les neuroleptiques classiques
- C. Ont une meilleure efficacité sur les symptômes négatifs de la schizophrénie par rapport aux neuroleptiques classiques
- D. Ont moins d'effet incisif que les neuroleptiques classiques
- E. peuvent induire un syndrome métabolique
- F- ne donnent pas un SMN

Réponse: C-E

19- La dissociation se traduit au niveau de la sphère des affects par :

- A. L'alogie
- B. l'anhédonie
- C. l'avolition
- D. la dysphorie
- E. l'ambivalence affective

Réponse: E

20- Parmi ces propositions lesquelles sont en faveur du diagnostic de schizophrénie :

A- le fléchissement scolaire et la désocialisation

B- la présence de symptômes thymiques au premier plan

C- la normalité de l'examen somatique

D- les traits de personnalité schizoïde

E- l'intervalle libre de bonne qualité entre les décompensations

Réponse: A-C-D

21- Devant une symptomatologie délirante évoluant depuis 3 mois chez un jeune de 23, les éléments suivants sont en faveur d'une évolution vers la schizophrénie:

- A. L'absence de symptômes confusionnels ou perplexité
- B. La présence d'un émoussement affectif
- C. La bonne intégration socioprofessionnelle prémorbide
- D. La présence d'antécédents familiaux de troubles psychotiques
- E. La notion de consommation de substances psychoactives

Réponse: A-B-D

22- un patient suivi pour schizophrénie et mis sous Halopéridol à la dose de 10 mg par jour, consulte aux urgences pour fièvre à 40°C :

A/ Quel diagnostic vous évoquez en premier lieu ?

Syndrome malin des neuroleptiques

B/ Quels sont les signes à rechercher pour étayer votre hypothèse diagnostique ?

- Rigidité musculaire
- Troubles de la conscience, Confusion, Convulsions
- Hyper / ou hypotension
- Tachypnée ou sialorrhée
- Tremblements
- Troubles de la coordination
- Rhabdomyolyse et insuffisance rénale

C/ Quel hypothèse diagnostique il faudrait évoquer en deuxième lieu devant ce tableau ?

Un syndrome infectieux

D/ quels sont les explorations que vous demanderez en première intention ?

- CPK, LDH
- NFS
- CRP
- Ionogramme sanguin
- Fonction rénale

E/ quel serait votre conduite à tenir dans l'immédiat ?

- Hospitalisation
- Arrêt du traitement neuroleptique est impératif et doit être immédiat
- Le traitement symptomatique par refroidissement
- sédation et ventilation assistée et mesures de réanimation dans les formes graves ou avec altération de l'état de conscience

23- Les antipsychotiques atypiques :

- A-Ont une action protectrice des fonctions cognitives par rapport aux neuroleptiques classiques
- B- Aggravent les symptômes négatifs de la schizophrénie
- C-Exposent au même risque d'effets indésirables métaboliques que les neuroleptiques classiques
- D- sont indiqués en première intention dans la schizophrénie
- E- augmentent le risque de maladies cardiovasculaires

Réponse: A-D-E

24- les effets indésirables pouvant mettre en jeu le pronostic vital d'un patient sous antipsychotiques sont :

- A. le syndrome extrapyramidal
- B. L'agranulocytose
- C. L'iléus paralytique
- D. hyperthermie centrale
- E. l'allongement de l'espace QT à l'ECG

Réponse: B-C-E-F

25- Un patient âgé de 30 ans, suivi pour schizophrénie et mis sous Halopéridol à la dose de 15 mg/j depuis 2 jours, consulte pour l'installation d'une rigidité musculaire et des crises de plafonnement des yeux.

A/ Quel est votre diagnostic positif devant ce tableau ?

Crise oculogyre / dyskinésie aiguë

B/ quelle sera votre conduite à tenir ?

Prescription d'un antiparkinsonien anticholinergiques (exp: bipéridène)

Diminuer la dose du neuroleptique prescrit en gardant la dose minimale efficace

Une amélioration de la symptomatologie a été notée dans les suites de votre conduite thérapeutique, 7 mois après cette consultation, le patient sollicite votre avis pour l'installation de mouvements anormaux et involontaires de la langue, de la mâchoire et du tronc. Ces mouvements sont de type choréiforme (rapides, saccadés, non répétitifs) et athétosique (sinueux, lents, continus) évoluant depuis 5 semaines. Le reste de l'examen est sans anomalies

C/ Quel est votre diagnostic positif devant ce tableau ?

Dyskinésie tardive

Cas clinique I :

- Monsieur M.H, âgé de 25 ans est amené aux urgences par sa famille pour des troubles du comportement à type d'hétéroagressivité physique et verbale envers son entourage évoluant depuis deux mois, avec aggravation depuis 3 semaines.
- Cette symptomatologie a été précédée par une période de 8mois faite de repli sur soi, arrêt de toute activité, soucis et sentiment d'étrangeté par rapport à l'apparence physique, un discours incohérent entrecoupé par des silences brusques, l'utilisation de mots nouveaux incompréhensibles.
- A l'examen : sa présentation est négligée, il refuse la main tendue et répond difficilement aux questions posées. Il rapporte par ailleurs que les voisins et les animateurs de la télé disent du mal de lui. Il se sent menacé par les voisins qui veulent lui faire du mal.

1/ le tableau clinique de M.H comporte les symptômes suivants :

- A. Dépersonnalisation
- B. syndrome de référence
- C. syndrome d'influence
- D. délire de persécution
- E. Fading mental
- F. barrage

Réponse: A-B-D-F

2/ le ou les diagnostic(s) qui peut (vent) être évoqué(s) devant ce tableau est (sont) :

- A. Trouble schizophréniforme
- B. Un trouble délirant
- C. Un trouble bipolaire
- D. Une schizophrénie
- E. Psychose hallucinatoire chronique

Réponse:D

3/ votre prise en charge comportera :

- A. La mise sous Halopéridol décanoate
- B. La mise sous un antipsychotique atypique
- C. Des séances d'électroconvulsivothérapie
- D. Une hospitalisation en milieu psychiatrique
- E. Un thymorégulateur

Réponse: B-D

3/ votre bilan étiologique de première intention comportera :

- A. Un bilan thyroïdien
- B. Une imagerie cérébrale
- C. Un bilan toxicologique
- D. Une cortisolémie
- E. Un bilan immunologique

Réponse: B-D-C

4/ votre bilan préthérapeutique comportera :

- A. une glycémie à jeun
- B. Un dosage de la TSH
- C. un ECG
- D. un bilan rénal
- E. Une NFS

Réponse: A-C-D-E

Cas Clinique II :

- Patiente A, âgée de 20 ans, consulte en psychiatrie, accompagnée par ses parents.
- La patiente n'investit aucune activité sociale ou professionnelle depuis environ 3 ans et semblait souvent apathique. Elle s'enferme assez souvent dans sa chambre et on l'entend parler toute seule. Selon ses parents, il y a eu une aggravation des symptômes depuis une semaine avec refus alimentaire sélective, elle refuse les plats préparés à la maison et ne mange que des conserves qu'elle achète toute seule. Par ailleurs, elle refuse que la famille entre dans sa chambre et vérifie fréquemment que sa chambre est fermée à clé.
- A l'entretien, la patiente reste méfiante, ayant un discours pauvre et provoqué, elle regarde fréquemment le plafond avec poursuite oculaire d'un « objet invisible », en lui posant la question concernant le motif de consultation elle répond : « tu n'as qu'à demander à mes parents, moi je n'ai rien, c'est eux qui veulent m'empoisonner, mais je suis protégée par un ange, il est d'ailleurs ici et il vous punira tous... »
- L'examen somatique et les explorations paracliniques sont normaux
- A noter par ailleurs qu'il s'agit de sa première consultation en psychiatrie

1/ Le tableau clinique présenté dans cette vignette comporte :

- A. Un syndrome d'influence
- B. Un syndrome délirant de persécution et d'empoisonnement
- C. Un syndrome dissociatif
- D. Un petit automatisme mental
- E. Un syndrome anxieux

Réponse: B-C

2/Le diagnostic qui vous paraît le plus probable est :

- A. épisode dépressif caractérisé avec caractéristiques psychotiques
- B. Trouble délirant de persécution
- C. Schizophrénie
- D. Trouble schizophréniforme
- E. Trouble obsessionnel compulsif

Réponse: C

4/Les éléments de mauvais pronostic dans ce tableau sont :

- A. Le mauvais fonctionnement prémorbide
- B. La présence de délire
- C. La durée de psychose non traitée
- D. L'âge de début de la maladie
- E. Le sexe féminin

Réponse: A-C-D

5/ parmi les molécules suivantes laquelle ou lesquelles vous pouvez prescrire en première intention et en monothérapie chez cette patiente

- A. Amisulpiride à la dose de 100 mg/j
- B. Halopéridol à la dose de 15mg/j
- C. Risperidone à la dose de 4mg/j
- D. Clozapine à la dose de 450mg/j
- E. Chlorpromazine à la dose de 200mg/j

Réponse: C

Merci pour votre attention
et
Bon courage